

(/) ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

ROGERIO PERES GOMES

IDADE: 44 PESO: 115 ALTURA: 178 PROFISSÃO: gerente Tecnologia
SINTOMAS: Fadiga muscular
QUEIXAS: Sonolência (durante a manhã) cansaço
MEDICAMENTOS: Reconten / Novaucho / Brasad /
PA ↑ (18 x 12) - Ansiedade
MÉDICO: Drº São Batista / Drº Marco Aurélio
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N
EXERCÍCIO FÍSICO: não faz (joga 3x semana)
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S (23:30)
HORA QUE DORME: 1 hr HORA QUE ACORDA: 6:30
COCHILHO (X) SIM () NÃO De manhã DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: oral BANHEIRO: 3X
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 46
OVERLAP: Sim MALLAMPATI: IV IAH: 86.6 efv SPO2: 48%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Sima (bombraba).
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: Provável
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA
(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS Dr Lombard
03/06/24 Avaliação masc. Mirage Fx

10/06 P= 10cmH₂O

24 IAH= 2.6 efv

m. de uso: 6h17'

melhora dos sintomas clínicos. J

05/07

P= 10cmH₂O

24

IAH= 0,7 efv

m. de uso: 4h39'

fu

19/07

P= 10cmH₂O

25

m. de uso: 5hr

Fuga= 2.1 lpu

IAH= 0,7 efv

fu

Nome: ROGERIO PERES GOMES
Data de Nascimento: 25-5-1980
IMC: 35,51
Sexo: Masculino
Data do exame: 11-04-2024

Peso: 110 kg
Altura: 1,76 m
Médico: DR. JOÃO BATISTA ALVES DE
OLIVEIRA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 11-04-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 582,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 38,5 e 114,0 minutos. O tempo total de sono foi de 476,5 min, eficiência de 81,8% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,2%; estágio N2: 73,7%; estágio N3: 6,6%; sono REM: 17,5%. O índice de despertares foi de 57,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 86,6/hora, sendo 111 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 46 hipopnéias. A SpO2 média foi de 87% e a mínima de 48%, permanecendo 42,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 49 - 107 bpm e NREM de 48 - 98 bpm.

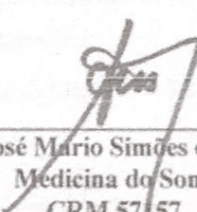
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (6), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 86,6/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=48%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157